

Recht

CE02 UE2

Aufbauschema

- ▶ Objektiver Tatbestand
- ▶ Subjektiver Tatbestand
 - ▶ Vorsätzlich oder fahrlässig
- ▶ Rechtswidrigkeit (Rechtfertigungsgründe)
 - ▶ Notwehr
 - ▶ Notstand
 - ▶ Einwilligung
- ▶ Schuld
 - ▶ Ist Täter schuldfähig?

Vorsatz

- ▶ Wissen und wollen
- ▶ Der Vorsatz ist dann erfüllt, wenn Täter wissentlich und willentlich gehandelt hat
- ▶ 3 unterschiedliche Formen
 - ▶ Absicht
 - ▶ Bsp.: Täter schießt absichtlich auf eine Katze
 - ▶ Direkter Vorsatz
 - ▶ Bsp.: Täter schießt mit dem Wissen, dass sich Katze im anvisierten Zielbereich aufhält
 - ▶ Eventualvorsatz (am häufigsten der Fall)
 - ▶ Täter weiß nicht, ob sich Katze im Zielbereich aufhält, vergewissert sich auch nicht, es ist ihm egal (billigend in Kauf nehmen)

Fahrlässigkeit

- ▶ Pflichtwidriges Außerachtlassen der im Verkehr gebotenen Sorgfalt
- ▶ <https://studyflix.de/wirtschaft/fahrlaessigkeit-5049>
- ▶ Unterschied zu Vorsatz:
 - ▶ Täter will nicht, dass Erfolg eintritt

Rechtswidrigkeit

- ▶ Tatbestand ist grundsätzlich als rechtswidrig einzustufen
- ▶ ES SEI DENN es liegen Rechtfertigungsgründe vor
- ▶ Notwehr (§32 StGB)
 - ▶ Angriff
 - ▶ Gegenwärtig (Angriff steht unmittelbar bevor, findet gerade statt)
- ▶ Notstand (§34)
 - ▶ Notstandslage: Gefahr, gegenwärtig, nicht anders abwendbar
 - ▶ Notstandshandlung: geeignetes Mittel, mildestes Mittel, Interessensabwägung (Schutzgut muss gegenüber Eingriffsgut wesentlich überwiegen)

Einwilligung

- ▶ 1. Voraussetzung:
 - ▶ Einsichts- und urteilsfähig
 - ▶ geistige + sittliche Reife
 - ▶ Schwere und Tragweite der Entscheidung muss erkannt werden
- ▶ 2. Voraussetzung: Aufklärung
- ▶ Fehlende Einwilligung verwirklicht Tatbestand der Körperverletzung
- ▶ Minderjährige unter 14: Einwilligung der Vertreter einzuholen
- ▶ Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren: Einwilligungsfähigkeit sehr genau prüfen

Formen der Einwilligung

- ▶ Ausdrückliche Einwilligung
 - ▶ Schriftlich
 - ▶ Mündlich
- ▶ Konkludente Einwilligung
 - ▶ Ergibt sich aus nonverbalem, schlüssigem Verhalten
 - ▶ Z.B. Unterbauch wird durch Pat. vor s.c.-Injektion freigemacht
- ▶ Mutmaßliche Einwilligung
 - ▶ Muss erforscht werden
 - ▶ Immer dann, wenn Pat. eigenen Willen nicht äußern kann
 - ▶ Z.B. bei Bewusstlosigkeit

Schuld

- ▶ Keine Strafe ohne Schuld
- ▶ Setzt voraus, dass Täter frei zwischen Recht und Unrecht entscheiden kann
- ▶ Wann führt rechtswidrige Tat nicht zur Bestrafung?
 - ▶ Wenn Voraussetzung der Schuldfähigkeit nicht gegeben ist
 - ▶ Ein Entschuldigungsgrund vorliegt
 - ▶ Der Täter nicht im Bewusstsein handelt Unrecht zutun

Rechtlicher Hintergrund

- ▶ Jede Art von Injektion ist eine Körperverletzung (§223 StGB)
- ▶ Injektionen erfordern Einwilligung des Patienten
- ▶ Einwilligung erfolgt nach ärztlichen Aufklärung
- ▶ Patient hat immer Verweigerungsrecht
 - ▶ Auch nach vorausgegangener Einwilligung
- ▶ Injektionen nur nach ärztlicher Anordnung
- ▶ Überträgt der Arzt die Durchführung an Pflegekraft: Delegationsverantwortung
- ▶ Nimmt Pflegekraft Delegation an und führt aus: Durchführungsverantwortung
- ▶ Jegliche Injektionen müssen unverzüglich und vollständig dokumentiert werden

StGB § 223 Körperverletzung

- ▶ (1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft
- ▶ (2) Der Versuch ist strafbar
- ▶ Antragsdelikt
 - ▶ Opfer muss Strafantrag stellen
 - ▶ Wenn kein Strafantrag gestellt wird, wird es auch nicht strafrechtlich verfolgt

StGB § 226 schwere Körperverletzung

- ▶ (1) Hat die Körperverletzung zur Folge, dass die verletzte Person
 - ▶ 1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert,
 - ▶ 2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder
 - ▶ 3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder Behinderung verfällt,
- ▶ so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
- ▶ Offizialdelikt
 - ▶ Straftat wird von Strafverfolgungsbehörde (Staatsanwaltschaft) von Amts wegen verfolgt (ohne Strafantrag)

Aufklärung

- ▶ Durch Aufklärung → Entscheidungsfreiheit ermöglicht
- ▶ Pat. Muss wissen, in was er einwilligt
- ▶ Kann NICHT an Pflegepersonal delegiert werden
- ▶ Zeitpunkt der Aufklärung:
 - ▶ Ambulanter Eingriff
 - ▶ Aufklärung am OP Tag ausreichend

- 
- ▶ Stationärer Eingriff
 - ▶ Unterschiedliche Auffassung der Rechtsprechung
 - ▶ Sobald Termin vereinbart: Aufklärungspflicht
 - ▶ Sollte vor stationären Aufnahme erfolgen
 - ▶ Nicht ausreichend am OP Tag
 - ▶ Wenn Pat das erste mal von gravierenden Risiken erfährt
 - ▶ Ausreichend am OP Tag
 - ▶ Narkoseaufklärung
 - ▶ OPs mit geringen und wenig einschneidenden Risiken
 - ▶ Aufklärung auf keinen Fall wirksam:
 - ▶ Mit Gabe der OP vorbereitenden Medikamente
 - ▶ Auf dem OP Tisch
 - ▶ Pat. Sollte zwischen Aufklärung und OP Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen

Delegationsverantwortung

- ▶ Durchführung einer Injektion: Verantwortungsbereich Arzt
- ▶ Kann jedoch an qualifiziertes Personal delegiert werden
- ▶ Vor Delegation muss Arzt sich über folgende Dinge ein Bild machen:
 - ▶ Objektive Gefährlichkeit der Tätigkeit
 - ▶ Subjektive Fähigkeit der Pflegekraft

Objektive Gefährlichkeit

- ▶ Hängt ab von
 - ▶ Häufigkeit der möglicherweise auftretenden Komplikationen (Komplikationsdichte)
 - ▶ Risikograd der Tätigkeit (Gefährdungsgrad)
- ▶ Injektionen, die in jedem Fall vom Arzt durchzuführen sind
 - ▶ Röntgenkontrastmittel
 - ▶ Herzmedikamente
 - ▶ Zytostatika
 - ▶ Mittel, bei denen häufig Zwischenfälle auftreten

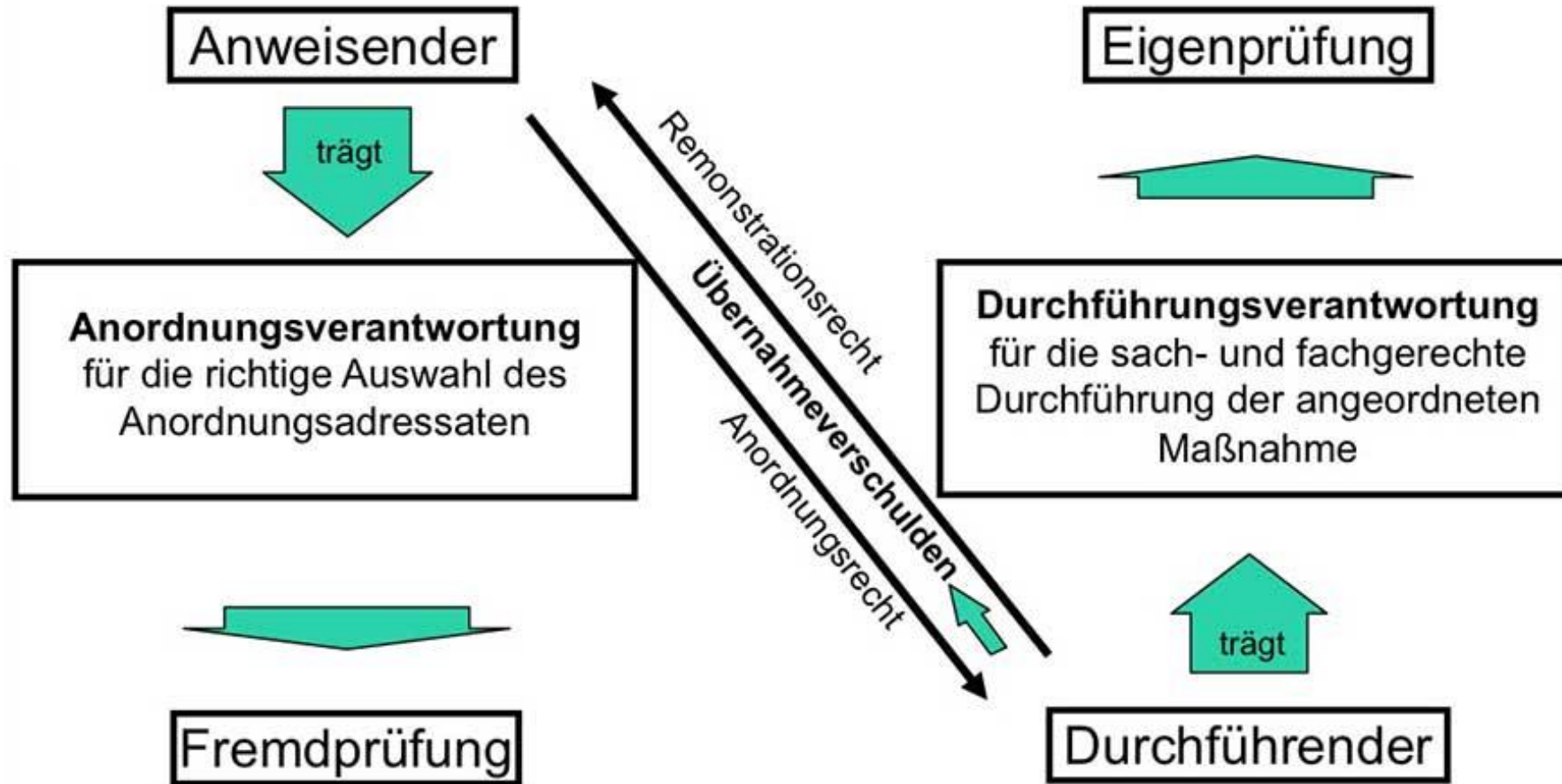
Subjektive Fähigkeit

- ▶ Abhängig von formeller Qualifikation → die durch Ausbildungszeugnis bescheinigte Fähigkeit
- ▶ Rein rechtlich sind Auszubildende in Pflegeausbildung nicht formell qualifiziert
- ▶ Regelung:
 - ▶ Auszubildende dürfen unter Aufsicht und zum Zwecke der Ausbildung Injektion vornehmen
 - ▶ In diesem Fall obliegt Durchführungsverantwortung der anleitenden Pflegekraft
- ▶ Abhängig von materieller Qualifikation
 - ▶ Beherrschung der Injektionstechnik
 - ▶ Kenntnis über (Neben-)Wirkungen des Arzneimittels
 - ▶ Kenntnisse über Krankenbeobachtung
 - ▶ Fähigkeit zur Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen

Durchführungsverantwortung

- ▶ Pflegekraft trägt Verantwortung für fach- und sachgerechte Ausführung der angeordneten Maßnahme
- ▶ Pflegekraft darf grundsätzlich davon ausgehen, dass Anordnungen fach- und sachgerecht sind (jedoch KEIN blindes Vertrauen!)
 - ▶ Besteht Grund zur Annahme, dass Anordnung nicht korrekt ist, darf dieser Anordnung nicht gefolgt werden
- ▶ Arzt darf grundsätzlich davon ausgehen, dass Pflegekraft entsprechend befähigt ist (jedoch KEIN blindes Vertrauen)
- ▶ Bei Übernahme einer Tätigkeit, der Pflegekraft nicht gewachsen ist: Übernahmeverschulden
- ▶ Kann Pflegekraft Maßnahme nicht ausführen, hat sie Pflicht diese zu verweigern → Remonstrationspflicht/Remonstrationsrecht
- ▶ Wenn Pflegekraft ohne ärztliche Anordnung handelt → Gesamtverantwortung

Verantwortungszuordnung



Fallbericht

- ▶ Dies dürfte der klassische Albtraum von Medizin und Pflege sein: Eine Patientin stellt sich in der Notaufnahme eines Klinikums vor; die diensthabende, frisch approbierte Ärztin lässt von einem Pfleger eine Spritze aufziehen. Dieses Medikament ist jedoch bei jener Patientin kontraindiziert, was für erfahrenere Ärzte klar erkennbar gewesen wäre. Nach Verabreichen der Injektion verstirbt die Frau. Wer ist nun strafrechtlich belangbar – die Ärztin oder der Pfleger, oder sogar beide?
- ▶ Die Lösung des Falles: Während sich die Ärztin tatsächlich wegen fahrlässiger Tötung verantworten musste, kam der Pfleger – der ihre Anweisung befolgte – davon. „Der Angewiesene darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass die Anweisung sach- und fachgerecht ist“, erläuterte Großkopf. „Allerdings gibt es kein blindes Vertrauen: Sobald beim Pfleger Anhaltspunkte dafür auftreten, dass die Anweisung falsch ist, darf der Angewiesene sie nicht befolgen.“

Sonderproblem telefonische Anordnung

- ▶ Gefahr von Hör- und Übermittlungsfehlern
- ▶ Im Schadensfall: Verantwortung beim Arzt
 - ▶ Er hat sich für diese Anordnungsweise entschieden
- ▶ Zur Vermeidung von Fehlern: gegenseitige Wiederholung
- ▶ Zusätzlich Verschriftlichung der Anordnung durch Pflegekraft
 - ▶ Späteres Abzeichnen durch Arzt

Sonderproblem Bedarfsmedikation

- ▶ Bedarfsmedikation
 - ▶ Arzt ordnet best. Medikament an, welches im Bedarfsfall verabreicht werden soll
- ▶ Ärztliche Anordnung erfolgt nicht auf aktuelle Situation
 - ▶ Wird in Literatur als unzulässig erachtet
 - ▶ Pflegekraft wird Ermessungsspielraum im diagnostischen und therapeutischen Bereich überlassen
 - ▶ Pflegekraft grundsätzlich nicht befugt solche Entscheidungen zu treffen
- ▶ Folgendes muss schriftlich fixiert werden
 - ▶ Art und Dosis des Medikaments
 - ▶ Konzentration des Arzneimittels
 - ▶ Zeitpunkt und Art der Verabreichung
 - ▶ Ggf. messbare Parameter

Quellen:

- ▶ *Großkopf, Volker; Klein, Hubert, Recht in Medizin und Pflege, 2019, 5. überarbeitete Auflage, spitta*
- ▶ <https://www.rechtsdepesche.de/bei-aufgaben-delegation-und-substitution-ist-vorsicht-geboten/>